



Doenças Orais e Nutrição em Gastroenterologia

Apostila — Parte 2 | Páginas 61–120

Esta seção aborda as principais lesões orais pré-malignas, doenças mucocutâneas e suas correlações com condições sistêmicas e nutricionais — conteúdo essencial para o raciocínio clínico integrado do especialista em gastroenterologia.

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

GASTROENTEROLOGIA

Roteiro da Parte 2

O Que Vamos Estudar

01

Lesões Pré-Malignas

Leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica e suas características clínicas, diagnóstico e manejo.

03

Neoplasias Orais

Carcinoma espinocelular: epidemiologia, estadiamento, tratamento e prognóstico.

02

Doenças Mucocutâneas

Líquen plano, lúpus eritematoso, GVHD e HPV — manifestações orais e risco oncológico.

04

Integração Sistêmica e Nutricional

Manifestações orais de doenças gastrointestinais e deficiências nutricionais. Raciocínio clínico integrado.

Lesões Orais Pré-Malignas — Visão Geral

As lesões pré-malignas da cavidade oral representam um grupo crítico de condições com potencial de transformação em **carcinoma espinocelular** (CEC), o tumor maligno mais frequente da boca. Sua identificação precoce é um dos maiores impactos que o médico pode ter na redução da mortalidade por câncer oral.

Embora frequentemente assintomáticas nas fases iniciais, essas lesões fornecem uma janela de oportunidade terapêutica inestimável. O reconhecimento clínico criterioso, seguido de biópsia e acompanhamento estruturado, transforma o desfecho do paciente de forma radical.

Intervenção Precoce

Tratamento antes da malignização melhora drasticamente o prognóstico e reduz a morbidade do procedimento.

Redução da Mortalidade

O diagnóstico em estágio pré-maligno está associado a taxas de sobrevida muito superiores ao diagnóstico tardio.

Monitoramento Estruturado

Protocolos de reavaliação periódica permitem detectar progressão e agir no momento certo.

Fatores de Risco para Malignização

Principais Fatores Etiológicos

A compreensão dos fatores de risco é fundamental para identificar pacientes com maior probabilidade de transformação maligna e direcionar o acompanhamento mais rigoroso.

- **Tabagismo** — maior fator de risco isolado; o tabaco contém mais de 70 carcinógenos conhecidos com ação direta na mucosa oral
- **Etilismo** — o álcool atua como solvente, potencializando a penetração de carcinógenos na mucosa
- **Infecção por HPV** — especialmente os subtipos 16 e 18, associados a carcinoma orofaríngeo em pacientes jovens
- **Irritação crônica** — próteses mal adaptadas, bordas dentárias afiadas e trauma repetitivo criam microambiente inflamatório propício
- **Imunossupressão** — pacientes transplantados, em uso de imunossupressores ou com HIV têm risco aumentado substancialmente

Efeito Sinérgico: Álcool + Tabaco

A associação entre álcool e tabaco não é meramente aditiva — ela é **sinérgica**. Estudos demonstram que indivíduos que fumam e bebem têm risco até **15 vezes maior** de desenvolver câncer oral em comparação com não expostos.

O mecanismo envolve:

- Alteração da permeabilidade da barreira mucosa pelo álcool
- Maior absorção local de nitrosaminas e outros carcinógenos do tabaco
- Comprometimento dos mecanismos de reparo do DNA por ambas as substâncias
- Efeito inflamatório crônico cumulativo

❏ A cessação tabágica e alcoólica é, isoladamente, a intervenção mais eficaz na prevenção do câncer oral.

Leucoplasia Oral — Revisão Clínica

A **leucoplasia** é definida pela Organização Mundial da Saúde como *"uma placa ou mancha branca da mucosa oral que não pode ser removida por raspagem e não pode ser classificada clinicamente ou histologicamente como qualquer outra doença"*. Trata-se, portanto, de um diagnóstico de exclusão.

É a **lesão pré-maligna mais comum da cavidade oral**, com prevalência estimada entre 1 e 4% na população adulta. Sua taxa de transformação maligna varia amplamente — de 0,13% a 17,5% —, dependendo de características clínicas, histológicas e do perfil do paciente.

Localização Típica

Mucosa jugal, gengiva, borda lateral da língua e assoalho da boca. Lesões na língua e assoalho apresentam maior risco de malignização.

Aspectos Clínicos

Placa branca, de bordas bem ou mal delimitadas, com textura variável — lisa, rugosa ou verrucosa. Pode ser única ou multifocal.

Prevalência

Mais frequente em homens acima de 40 anos, com histórico de tabagismo. Incidência aumenta progressivamente com a idade.

Classificação da Leucoplasia

A classificação da leucoplasia é clinicamente relevante porque orienta diretamente o risco de transformação maligna e a urgência da conduta.

Leucoplasia Homogênea — Menor Risco

Apresenta superfície uniforme, branca, com textura plana ou levemente rugosa. As bordas são bem definidas e a espessura é relativamente constante. Histologicamente, costuma mostrar apenas hiperqueratose ou displasia leve. Taxa de transformação maligna inferior a 5%.

Leucoplasia Não Homogênea — Maior Risco

Superfície irregular, com áreas de eritema mescladas ao branco, textura verrucosa ou nodular. Inclui três subtipos de **alto risco**:

- **Eritroleucoplasia (leucoplasia mista):** combinação de áreas brancas e vermelhas — risco de malignização de 20–40%
- **Verrucosa:** projeções papilares brancas, superfície irregular; associada à leucoplasia verrucosa proliferativa
- **Nodular:** pequenas excrescências arredondadas brancas ou vermelhas sobre fundo eritematoso

❏ Qualquer componente vermelho em uma leucoplasia eleva significativamente o risco e exige biópsia imediata.

Leucoplasia Verrucosa Proliferativa

Uma Forma Especialmente Agressiva

A **Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP)** representa a variante mais agressiva do espectro leucoplásico. Caracteriza-se por crescimento progressivo, multifocal e com padrão verrucoso exuberante. Acomete preferencialmente mulheres na sexta e sétima décadas de vida, frequentemente sem relação com tabagismo.

Seu comportamento biológico é particularmente preocupante:

- **Crescimento progressivo e expansivo** — tende a envolver múltiplas regiões da mucosa ao longo do tempo
- **Recorrência frequente** após excisão cirúrgica, com taxas superiores a 80%
- **Alta taxa de transformação maligna** — estimada entre 60–70% em séries de longo prazo
- **Multifocalidade** — dificulta o controle cirúrgico e exige vigilância de toda a mucosa oral

Manejo e Desafios

Não existe consenso sobre o tratamento ideal. A excisão cirúrgica é a abordagem mais utilizada, porém as recorrências são quase inevitáveis. Algumas evidências sugerem benefício com:

- Terapia fotodinâmica
- Retinoides sistêmicos (uso limitado por efeitos adversos)
- Acompanhamento em serviço especializado

❏ A LVP exige acompanhamento vitalício em serviço especializado, dada sua natureza recorrente e alto potencial maligno.

Diagnóstico da Leucoplasia



O diagnóstico da leucoplasia é essencialmente clínico-patológico. A **persistência por mais de 6 semanas** é critério fundamental — lesões que regredem com a remoção de um fator irritante (como uma prótese mal adaptada) não são leucoplasia verdadeira. A exclusão de candidíase oral, nevo branco esponjoso e outras lesões brancas deve ser feita antes de firmar o diagnóstico. A **biópsia é obrigatória** em qualquer lesão com características suspeitas ou que não regride após eliminação do fator causal, sendo o único método capaz de determinar o grau de displasia e orientar o tratamento.

Histopatologia da Leucoplasia

O exame histopatológico é decisivo para estratificar o risco e definir a conduta. O espectro de achados vai desde alterações benignas até lesões com potencial maligno elevado.

1

Hiperqueratose Simples

Aumento da camada córnea sem atipia celular. Menor risco de progressão.

2

Displasia Leve

Alterações arquiteturais e citológicas restritas ao terço inferior do epitélio.
Acompanhamento clínico rigoroso.

3

Displasia Moderada

Comprometimento até os dois terços do epitélio. Risco intermediário — considerar excisão.

4

Displasia Grave / Carcinoma In Situ

Alterações em toda a espessura epitelial, sem invasão da membrana basal. Excisão imediata mandatória.

Conduta Clínica e Tratamento da Leucoplasia

Fatores que Norteiam a Decisão

A conduta na leucoplasia não é uniforme — deve ser individualizada com base em três parâmetros principais:

- **Tamanho da lesão:** lesões maiores que 2 cm têm maior risco e exigem abordagem mais agressiva
- **Localização:** assoalho da boca, borda lateral da língua e palato mole são sítios de maior risco
- **Grau de displasia:** displasia moderada a grave indica tratamento ativo; hiperqueratose pode ser acompanhada

Modalidades Terapêuticas

- **Excisão cirúrgica convencional** — método preferencial, com margens livres; permite análise histológica completa da peça
- **Cirurgia a laser (CO₂)** — especialmente útil para lesões extensas ou em áreas de difícil acesso; menor morbidade cirúrgica
- **Crioterapia** — alternativa para lesões menores em pacientes sem condições cirúrgicas
- **Vigilância ativa** — reservada a lesões homogêneas pequenas sem displasia, com reavaliação a cada 3–6 meses

❏ A taxa de recorrência da leucoplasia após tratamento varia de 15 a 30%, justificando o monitoramento contínuo mesmo após excisão completa.

ALTA PRIORIDADE CLÍNICA

Eritroplasia — A Lesão de Maior Risco

A **eritroplasia** é definida como uma lesão vermelha da mucosa oral que não pode ser clinicamente ou patologicamente atribuída a qualquer outra condição específica. Embora menos prevalente que a leucoplasia, possui o **maior potencial maligno entre todas as lesões pré-malignas orais** — com transformação em carcinoma estimada em **mais de 80% dos casos** em séries histopatológicas.

Superfície Aveludada

Aspecto clínico característico: placa vermelha, macia, de superfície aveludada, bem delimitada, com consistência firme à palpação.

Geralmente Assintomática

A ausência de dor ou desconforto contribui para o diagnóstico tardio. O paciente raramente percebe a lesão espontaneamente.

Localização Típica

Assoalho da boca, superfície ventral da língua e palato mole — regiões com mucosa mais fina e maior permeabilidade a carcinógenos.

Eritroplasia — Histopatologia e Conduta

Achados Histopatológicos

A eritroplasia apresenta os achados histopatológicos mais graves entre as lesões orais pré-malignas. Na maioria dos casos, a biópsia revela:

- **Displasia epitelial grave** — alterações citológicas e arquiteturais em toda a espessura do epitélio
- **Carcinoma in situ** — comprometimento total sem invasão da membrana basal
- **Carcinoma invasivo** — em proporção significativa dos casos ao momento do diagnóstico

A cor vermelha resulta da atrofia epitelial, que permite a visualização do plexo vascular subjacente — sinal indireto de hiperatividade proliferativa e inflamatória local.

Conduta — Urgência Diagnóstica e Terapêutica

Diante de qualquer lesão vermelha persistente na cavidade oral, a conduta deve ser imediata e assertiva:

- **Biópsia imediata** — sem aguardar resolução espontânea; não há margem para observação em lesões eritematosas persistentes
- **Excisão cirúrgica** — indicada em praticamente todos os casos confirmados, com margens de segurança adequadas
- **Seguimento rigoroso** — mesmo após excisão, risco de recorrência e de lesões sincrônicas ou metacrônicas

📌 Toda lesão vermelha persistente na boca deve ser considerada maligna até que se prove o contrário.

HPV e Cavidade Oral

O **Papilomavírus Humano (HPV)** é um vírus DNA de transmissão predominantemente sexual e por contato direto com mucosas infectadas. Na cavidade oral, está associado tanto a lesões benignas quanto ao desenvolvimento de carcinomas, especialmente na orofaringe.

Manifestações Benignas

- **Papiloma oral escamoso** — lesão exofítica pediculada, aspecto de couve-flor, geralmente causada por HPV 6 e 11; benigna, mas requer excisão
- **Condiloma acuminado** — múltiplas lesões verrucosas, associadas a HPV 6/11; frequente em mucosa labial e gengival
- **Hiperplasia epitelial focal (Doença de Heck)** — nódulos múltiplos na mucosa, HPV 13 e 32; mais comum em crianças e populações indígenas

Associação com Carcinoma

O HPV, especialmente os subtipos **16 e 18**, está fortemente associado ao carcinoma de orofaringe (base de língua, tonsilas palatinas). Este carcinoma HPV-positivo apresenta um perfil epidemiológico distinto:

- Pacientes mais jovens (40–60 anos)
- Não tabagistas ou leves
- Melhor resposta ao tratamento e maior sobrevida global
- Transmissão predominantemente sexual

❏ A vacinação contra HPV é a principal estratégia preventiva e está incluída no calendário vacinal do SUS para adolescentes.

Líquen Plano Oral — Introdução e Fisiopatologia

O **Líquen Plano Oral (LPO)** é uma doença inflamatória crônica imunomediada que afeta a mucosa oral, com prevalência estimada de 0,5 a 2% na população adulta. Predomina em **mulheres adultas**, entre a quarta e sexta décadas de vida, embora possa ocorrer em qualquer idade.

Fisiopatologia

O mecanismo central envolve a **destruição da camada basal epitelial por linfócitos T CD8+ citotóxicos**. Antígenos ainda não completamente identificados na membrana dos ceratinócitos basais desencadeiam uma resposta imune mediada por células, levando à apoptose progressiva das células epiteliais. O resultado histológico clássico é:

- Infiltrado linfocitário em banda na interface epitélio-tecido conjuntivo
- Degeneração hidrópica da camada basal
- Corpos de Civatte (ceratinócitos apoptóticos)

Formas Clínicas

- **Reticular** — estrias brancas entrelaçadas (estrias de Wickham), bilateral e simétrica na mucosa jugal; forma mais comum e assintomática
- **Erosiva** — áreas eritematosas com erosões centrais, muito sintomáticas; maior risco de transformação maligna
- **Atrófica** — mucosa fina e eritematosa, sem erosões francas; dor ao contato com alimentos ácidos ou condimentados

Líquen Plano Oral — Associações Sistêmicas e Risco Oncológico

Associações Sistêmicas Relevantes

O LPO não é uma doença isolada. Importantes associações sistêmicas devem ser investigadas:

- **Hepatite C** — associação bem estabelecida; o vírus HCV pode atuar como antígeno desencadeante da resposta imune no LPO. Prevalência de HCV em pacientes com LPO é 5–10 vezes maior que na população geral
- **Doenças autoimunes** — tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, doença inflamatória intestinal e outras condições autoimunes são mais frequentes nesses pacientes
- **Reações liquenoides a medicamentos** — AINEs, anti-hipertensivos (IECAs, betabloqueadores), antimaláricos e outros podem induzir lesões indistinguíveis clinicamente do LPO

Risco Oncológico e Seguimento

O potencial de transformação maligna do LPO é **baixo, porém real**, estimado em aproximadamente **1%** em estudos de longo prazo, com maior risco nas formas erosiva e atrófica. A OMS classifica o LPO como condição de potencial maligno.

O acompanhamento deve ser:

- Reavaliação a cada 6–12 meses nas formas estáveis
- Biópsia em caso de alterações na morfologia, endurecimento ou ulceração persistente
- Orientação para cessação tabágica e alcoólica

Tratamento

- **Corticoides tópicos** (propionato de clobetasol, betametasona) — primeira linha para formas sintomáticas
- **Imunomoduladores tópicos** (tacrolimus, pimecrolimus) — alternativa eficaz, especialmente nas formas erosivas

Lúpus Eritematoso Oral

Espectro de Apresentação

As manifestações orais do lúpus eritematoso podem ocorrer como:

- **Manifestação isolada** — lúpus eritematoso discoide (LED) com envolvimento oral sem critérios para LES
- **Parte integrante do LES** — úlceras orais indolores são critério diagnóstico formal de lúpus eritematoso sistêmico pelo ACR/EULAR

A prevalência de lesões orais no LES varia de 7% a 52% dependendo da série estudada, sendo frequentemente subestimada na prática clínica.

Manifestações Clínicas

- **Placas esbranquiçadas** com estriações radiadas, semelhantes ao líquen plano, porém assimétrias e com distribuição irregular
- **Úlcerações** — geralmente indolores, no palato duro, mucosa jugal e gengiva
- **Eritema difuso** — mucosa oral avermelhada e frágil, com telangiectasias

Diagnóstico e Tratamento

Diagnóstico:

- Biópsia com imunofluorescência direta — depósitos de IgG, IgM e C3 na zona da membrana basal (banda lúpica)
- Correlação clínica e laboratorial — ANA, anti-dsDNA, complemento sérico

Tratamento:

- **Corticoides tópicos** — para controle das lesões locais sintomáticas
- **Antimaláricos** (hidroxicloroquina) — base do tratamento sistêmico, com efeito protetor sobre as lesões mucosas
- **Imunossupressores sistêmicos** (azatioprina, micofenolato) — nos casos de doença ativa ou resistente

📌 Úlceras orais recorrentes em mulher jovem devem sempre incluir LES no diagnóstico diferencial.

Doença do Enxerto vs. Hospedeiro (GVHD)

Complicação do Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas

A **Doença do Enxerto vs. Hospedeiro (GVHD)** é uma das complicações mais graves do transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). Ocorre quando os linfócitos T do doador reconhecem tecidos do receptor como estranhos e desencadeiam uma resposta imune sistêmica. A cavidade oral é um dos órgãos-alvo mais frequentemente afetados, tanto na forma aguda quanto na crônica.

Lesões Liquenoides

Estrias brancas entrelaçadas, eritema e áreas de atrofia na mucosa jugal, língua e lábios — histologicamente idênticas ao líquen plano.

Úlceras Dolorosas

Úlceras recorrentes e extensas que comprometem a alimentação, a higiene oral e a qualidade de vida do paciente transplantado.

Xerostomia

Boca seca por comprometimento das glândulas salivares; predispõe a cáries, candidíase e dificuldade de deglutição.

Risco Oncológico Aumentado

Pacientes com GVHD crônico oral têm risco significativamente elevado de carcinoma espinocelular oral — requerem vigilância rigorosa e periódica.

GVHD Oral — Conduta e Vigilância

Manejo das Manifestações Orais

O tratamento das lesões orais no contexto de GVHD deve ser integrado ao manejo sistêmico da doença:

- **Intensificação da imunossupressão sistêmica** — corticoides orais, tacrolimus, ciclosporina conforme protocolo do serviço de transplante
- **Corticoides tópicos orais** — bochechos com suspensão de dexametasona ou budesonida para controle local das lesões
- **Imunomoduladores tópicos** — tacrolimus tópico 0,1% como alternativa ou adjuvante nos casos resistentes a corticoides
- **Fototerapia extracorpórea** — modalidade eficaz para GVHD crônico refratário

Programa de Vigilância Oncológica

Dado o risco aumentado de carcinoma espinocelular, pacientes com GVHD oral crônico devem ser acompanhados em programa de vigilância estruturado:

- Exame oral completo a cada 3–6 meses
- Biópsia de qualquer lesão suspeita (endurecimento, ulceração persistente, crescimento rápido)
- Orientação para higiene oral rigorosa e controle de candidíase
- Cessação tabágica mandatória

❏ A vigilância oncológica oral deve ser parte integrante do protocolo de seguimento de todo paciente submetido a TCTH alogênico.

Queilite Actínica

A **Queilite Actínica (QA)** é uma lesão pré-maligna do lábio inferior causada pela exposição crônica acumulada à **radiação ultravioleta**, principalmente UV-B. É considerada o análogo labial da queratose actínica cutânea. Sua importância clínica reside no alto potencial de transformação em carcinoma espinocelular labial — estimado entre 10 e 30%.

Perfil Epidemiológico

A QA tem distribuição epidemiológica bem definida:

- **Sexo masculino** — homens são até 5 vezes mais afetados que mulheres
- **Trabalhadores rurais** — agricultores, pescadores, trabalhadores de construção com exposição solar crônica sem proteção
- **Fototipo claro** — pele e olhos claros, com menor melanização protetora
- **Regiões de alta incidência solar** — Brasil, especialmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Manifestações Clínicas e Evolução

- **Fase inicial:** ressecamento e descamação do lábio inferior, com perda do brilho habitual da semimucosa
- **Fase intermediária:** eritema, edema, áreas de leucoplasia e superfície rugosa com fissuras
- **Fase avançada:** ulcerações, endurecimento palpável, apagamento do limite entre semimucosa e pele adjacente

❏ O apagamento do limite vermelhão-pele é sinal clínico sugestivo de progressão para carcinoma e indica biópsia imediata.

Queilite Actínica — Diagnóstico e Tratamento

Diagnóstico

O diagnóstico da queilite actínica é primariamente **clínico**, baseado nas características da lesão, localização (lábio inferior), e histórico de exposição solar. A **biópsia** está indicada quando há:

- Ulceração persistente sem cicatrização
- Endurecimento ou espessamento focal
- Lesão refratária ao tratamento
- Qualquer suspeita de malignização

Histologicamente, observam-se elastose solar no tecido conjuntivo, displasia epitelial em graus variáveis e eventualmente carcinoma in situ.

Modalidades Terapêuticas

- **Fotoproteção contínua** — protetor solar labial FPS ≥ 30 , chapéus de abas largas; medida preventiva e adjuvante ao tratamento
- **Terapias tópicas** — 5-fluorouracil tópico (5-FU), imiquimode 5%, diclofenaco 3% em gel de ácido hialurônico; indicados para lesões difusas
- **Terapia fotodinâmica** — alta eficácia com bom resultado cosmético; indicado especialmente para lesões moderadas a extensas
- **Vermelhectomia (shave labial)** — excisão cirúrgica de toda a semimucosa do lábio inferior; indicado para lesões extensas ou com displasia grave
- **Laser ablativo (CO₂, Er:YAG)** — alternativa cirúrgica com bom controle e resultado estético

Neoplasias Orais — Epidemiologia e Impacto

O **câncer de boca** representa um grave problema de saúde pública no Brasil. Com aproximadamente **15.000 novos casos por ano**, o país ocupa posição de destaque na incidência mundial. A mortalidade permanece elevada — em torno de 50% em cinco anos — reflexo do diagnóstico tardio, quando a doença já se encontra em estágios avançados.

15K

Novos Casos/Ano

Estimativa anual para o Brasil, segundo o INCA, tornando o câncer oral um dos mais prevalentes no país.

95%

Carcinoma Espinocelular

Proporção dos cânceres orais representada pelo CEC — o tipo histológico predominante e mais estudado.

50%

Sobrevida em 5 Anos

Taxa geral de sobrevida, que pode superar 80% em diagnósticos precoces (estágios I e II).

Carcinoma Espinocelular Oral — Características Clínicas

Fatores de Risco

O CEC oral tem etiologia multifatorial, com destaque para:

- **Tabaco** em todas as formas (cigarro, charuto, cachimbo, tabaco sem fumaça) — risco 6–7 vezes maior em fumantes pesados
- **Álcool** — risco dose-dependente; efeito sinérgico com tabaco eleva o risco em até 15 vezes
- **HPV 16 e 18** — especialmente associado ao carcinoma orofaríngeo; carcinomas HPV+ têm melhor prognóstico
- **Radiação UV** — carcinoma labial (lábio inferior), associado à queilite actínica
- **Condições pré-malignas** — leucoplasia, eritroplasia, líquen plano erosivo

Localização Mais Frequente

A localização é determinante no prognóstico. Os sítios de maior risco são:

- **Borda lateral da língua** — localização mais comum do CEC intraoral; difícil visualização espontânea pelo paciente
- **Assoalho da boca** — mucosa fina e altamente permeável; drena diretamente para nódulos cervicais
- **Palato mole e retromolar** — sítios de pior prognóstico por diagnóstico frequentemente tardio
- **Lábio inferior** — associado a exposição solar; melhor prognóstico global

❏ Qualquer lesão oral que não cicatriza em 3 semanas exige biópsia obrigatória — este é o sinal de alerta fundamental.

Lesões Associadas ao Carcinoma Espinocelular

O carcinoma espinocelular oral raramente surge de mucosa previamente saudável. Na maioria dos casos, evolui a partir de condições pré-malignas reconhecíveis. O conhecimento dessas lesões precursoras é estratégico para o diagnóstico precoce.



Leucoplasia

Lesão branca pré-maligna mais comum. Risco de transformação variável (0–17%), maior nas formas não homogêneas e com displasia moderada a grave. Localização em língua e assoalho aumenta o risco significativamente.



Eritroplasia

Lesão vermelha com altíssimo potencial maligno (>80%). Frequentemente já apresenta displasia grave ou carcinoma in situ na biópsia inicial. Toda lesão vermelha persistente deve ser considerada maligna até prova contrária.



Líquen Plano Erosivo

Entre as formas do LPO, a variante erosiva e atrófica apresenta maior potencial de transformação maligna (~1–2%). Requer monitoramento periódico e biópsia em caso de alterações morfológicas.

Estadiamento do Câncer Oral

O estadiamento do carcinoma espinocelular oral segue o sistema **TNM** (Tumor, Nódulo, Metástase) da UICC/AJCC, sendo determinante para a escolha do tratamento e para o prognóstico.

1

Tamanho do Tumor (T)

T1: ≤ 2 cm | T2: 2–4 cm | T3: >4 cm | T4: invasão de estruturas adjacentes (osso, músculo, pele). A profundidade de invasão (DOI) foi incorporada na 8ª edição do TNM como fator prognóstico independente.

2

Linfonodos (N)

Avaliação clínica e radiológica dos linfonodos cervicais. O comprometimento linfonodal é o fator prognóstico mais importante — reduz a sobrevida em 50%. A presença de extensão extracapsular piora ainda mais o prognóstico.

3

Metástases a Distância (M)

Ocorrem em apenas 5–10% dos casos ao diagnóstico. Pulmão, fígado e osso são os sítios mais frequentes. A presença de M1 classifica automaticamente como estágio IV e indica tratamento paliativo.

Tratamento e Prognóstico do Carcinoma Espinocelular Oral

Modalidades Terapêuticas

O tratamento do CEC oral é multimodal e depende do estágio, localização e condições clínicas do paciente:

- **Cirurgia** — pedra angular do tratamento; ressecção com margens livres adequadas (mínimo 5 mm). Inclui esvaziamento cervical eletivo ou terapêutico conforme estadiamento linfonodal
- **Radioterapia** — adjuvante pós-operatória em casos de alto risco (margens comprometidas, invasão perineural, extensão extracapsular); ou definitiva em casos inoperáveis
- **Quimioterapia** — usada em associação com radioterapia (quimiorradioterapia) no tratamento de tumores localmente avançados; cisplatina é o agente de primeira linha
- **Imunoterapia** — pembrolizumab e nivolumab aprovados para doença recorrente ou metastática

Prognóstico — O Impacto do Estágio

O estadiamento ao diagnóstico é o principal determinante do prognóstico:

- **Estágios I e II** — sobrevida em 5 anos de 70–90%; tratamento cirúrgico isolado frequentemente suficiente
- **Estágio III** — sobrevida de 40–60%; tratamento combinado cirurgia + radioterapia
- **Estágio IV** — sobrevida menor que 30%; tratamento complexo, multidisciplinar, com foco em qualidade de vida

❏ O diagnóstico precoce — em estágios I e II — multiplica por três a sobrevida em comparação ao diagnóstico tardio. Esta é a maior justificativa para o exame oral sistemático.

Integração com Gastroenterologia

A cavidade oral e o trato gastrointestinal compartilham origem embriológica, continuidade anatômica e mecanismos fisiopatológicos comuns. Doenças gastrointestinais frequentemente se manifestam na mucosa oral — às vezes como **primeiro sinal da doença subjacente**, antes mesmo de qualquer sintoma digestivo. O gastroenterologista que examina a boca de seus pacientes tem acesso a uma janela diagnóstica de enorme valor clínico.

Doença de Crohn

Aftas recorrentes e extensas, hiperplasia mucogengival, úlceras lineares profundas com aspecto de "pedra de calçamento" — podem preceder os sintomas intestinais em anos.

Doença Celíaca

Glossite atrófica, aftas recorrentes e hipoplasia do esmalte dentário são manifestações extraintestinais da enteropatia por glúten, reflexo da má absorção de nutrientes essenciais.

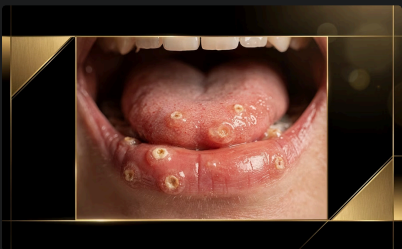
Deficiências Nutricionais

Ferro, vitamina B12 e ácido fólico — deficiências clássicas em doenças GI — produzem glossite, estomatite angular e ulcerações que o exame oral pode revelar antes dos exames laboratoriais.

Refluxo Gastroesofágico

Erosão do esmalte dentário na face palatina dos dentes posteriores — sinal patognomônico de refluxo crônico, especialmente em pacientes com perimólise assimétrica.

Exemplos Clínicos — Doenças GI e Manifestações Oraais



Doença de Crohn → Aftas

As aftas na DC tendem a ser maiores, mais profundas e mais dolorosas que as aftas comuns. Ocorrem em até 20–30% dos pacientes e podem ser a manifestação inicial da doença, inclusive na infância. A detecção de aftas atípicas deve provocar investigação intestinal completa.



Doença Celíaca → Glossite

A língua atrófica, lisa e avermelhada (glossite atrófica) é manifestação clássica da deficiência de ferro, B12 e folato associada à enteropatia por glúten. Frequente em adultos com celíaca não diagnosticada. A reversão ocorre com dieta sem glúten e reposição nutricional.



DRGE → Erosão do Esmalte

A perimólise — erosão química do esmalte por ácido gástrico — acomete preferencialmente a face palatina dos dentes posteriores superiores. É sinal de refluxo crônico e deve alertar o clínico para investigação da DRGE, especialmente em pacientes com sintomas atípicos.

A Boca como Espelho de Doenças Sistêmicas

A cavidade oral é o único segmento do trato gastrointestinal que pode ser inspecionado diretamente, sem tecnologia. Esta característica torna o exame oral uma **ferramenta diagnóstica de acesso universal e custo zero**. Para o médico com formação adequada, a inspeção da boca pode revelar diagnósticos que de outra forma demorariam meses para ser estabelecidos.

→ Primeira Manifestação de Doença Sistêmica

Doenças como Crohn, celíaca, deficiências nutricionais, doenças autoimunes e até hemopatias podem se manifestar na mucosa oral antes de qualquer outro sintoma. O olhar atento do médico pode antecipar o diagnóstico em semanas ou meses.

→ Marcador de Atividade de Doença

Em doenças já conhecidas, as lesões orais podem sinalizar exacerbação ou inadequado controle — como aftas numerosas em paciente com Crohn em crise, ou glossite em diabético com controle glicêmico deteriorado.

→ Indicador de Resposta ao Tratamento

A melhora das lesões orais com a terapia instituída confirma a relação causal e a eficácia do tratamento — como a reversão da glossite atrófica após reposição de ferro ou B12.

Papel do Médico no Diagnóstico das Lesões Orais

Competências Esperadas do Especialista

O médico especialista em gastroenterologia deve ser capaz de:

- **Reconhecimento precoce** — identificar lesões suspeitas durante a anamnese e exame físico rotineiro, sem aguardar encaminhamento odontológico
- **Classificação básica** — distinguir lesões brancas, vermelhas, ulceradas e mistas, reconhecendo padrões de alto e baixo risco
- **Encaminhamento adequado** — acionar cirurgião bucomaxilofacial, estomatologista ou oncologista conforme o grau de suspeição
- **Tratamento inicial** — iniciar cuidados básicos, orientar sobre fatores de risco modificáveis e estabelecer prazo para reavaliação

Integração à Prática Diária

O exame oral deve ser incorporado à rotina de avaliação do paciente gastroenterológico, especialmente em:

- Pacientes com doença inflamatória intestinal
- Pacientes com doença celíaca ou má absorção
- Transplantados (em especial TCTH alogênico)
- Imunossuprimidos por qualquer causa
- Usuários crônicos de álcool e tabaco
- Pacientes com queixas de aftas recorrentes ou dificuldade de deglutição

☐ Um exame oral completo leva menos de 2 minutos e pode mudar o curso clínico do paciente.

CAPÍTULO: NUTRIÇÃO E CAVIDADE ORAL

Nutrição e Cavidade Oral

A mucosa oral é um tecido de alta renovação celular — o epitélio oral se renova completamente a cada 7–14 dias. Esta característica torna-o extremamente sensível a **deficiências nutricionais**, que se manifestam de forma precoce e visível na cavidade oral, muitas vezes antes de alterações laboratoriais evidentes ou sintomas sistêmicos.

Para o gastroenterologista, as lesões orais de origem nutricional são especialmente relevantes porque frequentemente refletem **má absorção intestinal** — seja por doença celíaca, doença de Crohn, ressecção intestinal, gastropatia atrófica ou outras condições do trato GI. Identificar a lesão oral é o primeiro passo para investigar e tratar a doença subjacente.



Principais Deficiências Nutricionais e Manifestações Oraais

Deficiência de Ferro

A anemia ferropriva e a depleção isolada de ferro (sem anemia) produzem glossite atrófica com atrofia das papilas filiformes, mucosa oral pálida e seca, queilite angular (rachaduras nos cantos da boca), e disfagia por formação de membrana esofágica (Síndrome de Plummer-Vinson). O ferro é cofator essencial de enzimas envolvidas na síntese de DNA e proliferação celular epitelial.

Deficiência de Vitamina B12

A carência de cobalamina produz glossite atrófica dolorosa ("língua de Hunter"), com superfície lisa, avermelhada e brilhante. Pode haver parestesias na língua e úlceras aftosas recorrentes. A deficiência de B12 é particularmente comum em pacientes com gastrite atrófica, gastrectomia, doença de Crohn ileal e uso crônico de metformina ou inibidores de bomba de prótons.

Deficiência de Ácido Fólico

Clínica semelhante à deficiência de B12: glossite, estomatite, úlceras aftosas. O folato é essencial para a síntese de DNA e a proliferação das células epiteliais de alta renovação. Deficiência frequente em alcoolistas, em uso de metotrexato e em síndromes de má absorção do intestino delgado proximal.

Manifestações Nutricionais na Mucosa Oral

Glossite Nutricional

A **glossite** é a inflamação da língua caracterizada por eritema, edema, atrofia das papilas e dor. Constitui um sinal sensível (embora pouco específico) de deficiência nutricional. Na prática, a glossite atrófica (língua lisa, avermelhada, com perda das papilas filiformes) é o achado mais frequente, associado principalmente a:

- Deficiência de ferro, B12, folato
- Deficiência de vitaminas do complexo B (B2, B3, B6)
- Síndrome de má absorção em geral

A **língua geográfica** (glossite migratória benigna) pode ser exacerbada por deficiências nutricionais, embora tenha componente genético.

Estomatite e Ulcerações

A **estomatite angular** (queilite angular) — fissuras dolorosas nos ângulos da boca — é classicamente associada a deficiência de riboflavina (B2), ferro e zinco. Frequente em idosos, desnutridos e portadores de próteses mal adaptadas.

As **úlceras aftosas recorrentes** podem refletir:

- Deficiência de ferro, B12 ou folato
- Doença celíaca não diagnosticada
- Doença de Crohn
- Neutropenia cíclica

❏ Aftas recorrentes sem causa aparente devem incluir dosagem de ferritina, B12, folato e triagem para doença celíaca (anti-transglutaminase IgA).

Raciocínio Clínico Integrado

Lesão Oral = Investigar Causa Sistêmica

O princípio norteador da abordagem clínica das lesões orais é simples e poderoso: **toda lesão oral persistente ou recorrente deve provocar a busca ativa por uma causa sistêmica**. A mucosa oral não existe isolada do organismo — ela reflete o estado nutricional, imunológico e inflamatório do paciente como um todo.

Passo 1: Identificar

Examinar sistematicamente toda a cavidade oral — lábios, mucosa jugal, língua (dorso, ventre e bordas), assoalho, palato e orofaringe.

Passo 2: Classificar

Lesão branca? Vermelha? Ulcerada? Mista? Exofítica? Quanto tempo persiste? Recorre? É única ou múltipla?

Passo 3: Avaliar Fatores de Risco

Tabagismo, etilismo, imunossupressão, exposição solar, histórico de lesões pré-malignas, doenças sistêmicas conhecidas.

Passo 4: Decidir Biópsia

Lesão persistente >3 semanas, vermelha, mista, ulcerada sem causa óbvia ou que não responde ao tratamento — biópsia obrigatória.

Fluxo de Avaliação das Lesões Orais



Identificar Lesão

Classificar Risco

Avaliar Fatores

Decidir Biópsia

Este fluxo de avaliação sintetiza a abordagem sistemática recomendada para qualquer lesão oral encontrada na prática clínica. A sequência lógica garante que nenhuma lesão de alto risco seja negligenciada, ao mesmo tempo que evita procedimentos desnecessários em lesões claramente benignas e autolimitadas. A **decisão de biopsiar** deve ser baixa — é sempre melhor realizar uma biópsia desnecessária do que deixar um carcinoma precoce sem diagnóstico.

Erros Clínicos Comuns no Manejo das Lesões Orais

Os Três Erros Mais Frequentes

1 Subestimar Lesões

Tratar leucoplasias ou eritroplasias como "aftas" ou "feridas comuns", prescrevendo apenas bochechos antissépticos e aguardando resolução espontânea. Lesões que não regredem em 3 semanas não são aftas.

2 Não Biopsiar

Adiar indefinidamente a biópsia de lesões suspeitas, especialmente em pacientes assintomáticos. O custo de um carcinoma não diagnosticado é incomparavelmente maior que o de uma biópsia desnecessária.

3 Não Acompanhar

Alta médica sem protocolo de seguimento após diagnóstico de lesão pré-maligna tratada. A recorrência de leucoplasia chega a 30% — o paciente precisa ser monitorado continuamente.

Como Evitar Esses Erros

- **Regra dos 21 dias:** qualquer lesão oral que não cicatriza em 3 semanas exige avaliação especializada e biópsia
- **Documentação fotográfica:** fotografar lesões na primeira consulta permite comparação objetiva em reavaliações
- **Encaminhamento proativo:** não aguardar piora para encaminhar; o estomatologista ou CTBMF deve ser acionado precocemente
- **Protocolo de retorno:** definir data de retorno na própria consulta — "volte em 6 semanas" deve constar no prontuário
- **Educação do paciente:** orientar o paciente sobre os sinais de alerta e a importância do autoexame oral regular

☐ A documentação de lesões orais no prontuário — com descrição e fotografia — é fundamental para rastreamento da evolução e justificativa da conduta.

Visão de Especialista — A Boca na Prática Clínica Diária

"A cavidade oral é um marcador precoce de doenças sistêmicas e deve ser integrada à prática clínica diária de todo gastroenterologista. Não examinar a boca é deixar de ler o primeiro capítulo da história do paciente."

Esta perspectiva sintetiza o que os dados epidemiológicos, as séries clínicas e a experiência dos especialistas nos ensinam: o exame oral não é território exclusivo do dentista ou do estomatologista. É uma **responsabilidade compartilhada** de todo médico que cuida de pacientes com doenças sistêmicas, em especial as de natureza gastrointestinal, imunológica e nutricional.

A integração do exame oral à consulta gastroenterológica é uma mudança de paradigma simples, de baixo custo e de alto impacto. Ela não exige tecnologia — apenas conhecimento, atenção e o compromisso com o diagnóstico precoce.

Síntese Comparativa das Lesões Pré-Malignas

Lesão	Aspecto Clínico	Risco Maligno	Biópsia	Conduta
Leucoplasia homogênea	Placa branca, uniforme	Baixo (<5%)	Obrigatória	Excisão ou vigilância
Leucoplasia não homogênea	Branco + vermelho, irregular	Moderado–alto (20–40%)	Urgente	Excisão cirúrgica
Leucoplasia verrucosa proliferativa	Verrucosa, multifocal	Muito alto (60–70%)	Obrigatória	Excisão + vigilância vitalícia
Eritroplasia	Placa vermelha, aveludada	Altíssimo (>80%)	Imediata	Excisão imediata
Queilite actínica	Descamação, eritema labial	Alto (10–30%)	Em casos suspeitos	Fotoproteção + tratamento local
Líquen plano erosivo	Erosões, eritema, estrias	Baixo (~1–2%)	Confirmatória	Corticoides + acompanhamento

Síntese da Parte 2 — Mensagens-Chave

O Que Todo Especialista Deve Dominar



Diagnóstico Precoce Salva Vidas

A identificação de lesões pré-malignas antes da transformação maligna multiplica as chances de cura. O exame oral sistemático é a ferramenta mais poderosa de prevenção do câncer de boca.



Prevenção do Câncer Oral

Cessaç o tab gica, controle do etilismo, vacina  o anti-HPV, fotoprote  o labial e encaminhamento precoce s o as principais estrat gias preventivas ao alcance do m dico.



Abordagem Integrada com GI

A cavidade oral   parte do trato digestivo e reflete o estado sist mico do paciente. A integra  o da avalia  o oral   pr tica gastroenterol gica eleva a qualidade do cuidado de forma significativa.



Nutri  o como Determinante

Defici ncias de ferro, B12 e folato — frequentes em pacientes com doen as GI — produzem les es orais reconhec veis que orientam a investiga  o e o tratamento da causa subjacente.

Pontos de Fixação — Parte 2

Conceitos Fundamentais para Memorizar

Leucoplasia

Lesão branca pré-maligna mais comum. Biópsia obrigatória. Recorrência de 15–30% após tratamento.

Eritroplasia

Lesão vermelha, >80% de risco maligno. Biópsia imediata. Sempre considerar maligna até prova contrária.

Líquen Plano

Imunomediado, associado a hepatite C. Risco oncológico ~1%. Tratamento com corticoides tópicos.

GVHD Oral

Pós-TCTH alogênico. Lesões liquenoides, xerostomia, risco aumentado de CEC. Vigilância rigorosa.

Regras de Ouro da Prática Clínica

- Lesão oral que não cicatriza em **3 semanas** → biópsia obrigatória
- Qualquer componente **vermelho** em uma lesão branca → risco alto → biópsia urgente
- **Álcool + tabaco** = efeito sinérgico → risco até 15× maior
- **HPV 16/18** → carcinoma orofaríngeo em jovens não tabagistas
- **Aftas recorrentes** → investigar ferro, B12, folato, celíaca, Crohn
- **Glossite atrófica** → pensar em deficiência nutricional e má absorção GI
- **LVP** → forma mais agressiva da leucoplasia; vigilância vitalícia
- **Eritroplasia** → lesão pré-maligna com maior risco de transformação